Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 05

Abdome Vascular e Obstrutivo

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Abdome vascular e obstrutivo

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Dor desproporcional é isquemia até prova em contrário (angiotomografia, heparina, cirurgia e vascular); na obstrução, a pergunta é se há sofrimento: sim, cirurgia; não, e é brida, sonda, hidratação, gastrografina e até 72 horas.

1. **Embolia:** fibrilação atrial, dor súbita, abdome flácido.
2. **Angiotomografia já**; lactato normal não exclui.
3. **Trombose venosa:** anticoagular; operar se peritonite ou piora.
4. **Colite isquêmica:** idoso, dor e diarreia com sangue; suporte.
5. **Aneurisma roto:** dor, hipotensão, massa pulsátil: centro cirúrgico.
6. **Bridas sem sofrimento:** sonda, gastrografina, até 72 h.
7. **Volvo de sigmoide:** destorção endoscópica e sigmoidectomia na internação.
8. **Ogilvie:** suporte, neostigmina, descompressão.

Isquemia: mecanismo e pista

Tipo	Pista
Embolia	Arritmia
Trombose	Angina intestinal
Não oclusiva	Choque, vasopressor
Venosa	Trombofilia

Pegadinha

Sem cirurgia prévia, procure hérnia (inclusive femoral) e tumor, mas brida também acontece.

Checklist antes da prova

- ☐ Reconheço a dor desproporcional
- ☐ Sei os quatro mecanismos da isquemia
- ☐ Diferencio isquemia e colite isquêmica
- ☐ Reconheço o aneurisma roto
- ☐ Sei os sinais de estrangulamento
- ☐ Sei usar a gastrografina
- ☐ Sei conduzir volvo e Ogilvie